

Fecha Última Actualización: 10-01-2026 16:16:40

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Luis Alejandro Kramm Miranda
Edad : 34a 6m 16d
Dirección : Calle Creta 2659, V. Sor Teresa

Rut : 17.924.268-0
Fecha Nacto: 25/06/1991
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0530149
Sexo : Masculino
Teléfono : 955396393

N° Epicrisis
468368

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización

Fecha Ingreso : 09/01/2026 20:21

Días Estadía : 1

Unidad de Egreso : Emergencia Adulto

Fecha Egreso : 10/01/2026 16:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

CEG

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Med: tetraplejia por impacto de bala
Qx: herida de arma blanca con perforación intestinal
Med: baclofeno, pregabalina
Alergias: no
TBQ + OH + (refiere abundante en el pasado) Drogas THC +
Social: vive con madre, ant de encarcelamiento 2020

Paciente consulta por CEG, fiebre 38°C y tos con abundante expectoración mucopurulenta de 2 días, asociado a dolor torácico en borde inferior de clavícula izq. Ingres a con 3 L de O2.

Sin hemoptisis, sin baja de peso. Preso a principio de pandemia. Sin contacto con enfermos.

EF
Vigil, orientado TE
Bien hidratado, CRT<2
No palpo adenopat
RR2TSS taquicárdico
MP+ crepitos en base derecha, sin UMA
Abdomen globuloso, sin sensibilidad, no palpo masas
EEII sin edema, sin signos de TVP, con apositos sobre LPP en seguimineto ambulatorio

Hip Dg
NAC

Se hospitaliza por requerimientos de oxígeno.

Paciente actualmente en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, normotenso, normocárdico, afebril, con requerimientos de oxígeno.

Al examen físico

Fecha Epicrisis : 10/01/2026 16:16

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 10-01-2026 16:16:40

Página 2 de 3

Vigil reactivo OTE

Mucosas rosadas e hidratadas
Tibia a distal, llene capilar normal
MP + roncus bilaterales RR2T SS
ABDI RHA+ SSIP
MMII sin edema ni signos de TVP

Laboratorio

09/01
Ácido láctico 23.5, Ácido úrico 5.9, Bili T 0.18, Bili D <0.10, FA 69, GGT 21, GOT 25, GPT 10, Ca 8.0, crea 0.79, BUN 6.9, Glucosa 141, LDH 220, Magnesio 2.0, Proteínas totales 6.8, PCR 32.1, Hto 40.4, Hb 14.0, RDW 15.3, leuco 5.72, plaq 313, VCM 84.1, VPM 9.1, Na 133, K 3.18, Cl 106, GSV pH 7.490, P CO2 30.2, HCO3 22.5, EBVT -0.9
SO inflamatorio

Microbiología

Cultivo de expectoración células epiteliales menor a 10 por campo, leucocitos mayor a 25 por campo, cocáceas gram positivas abundante cantidad
PCR SARS CoV2 negativo
Panel viral respiratorio negativo
UC pendiente

Angiotac de torax 10/01

Examen negativo para tromboembolismo pulmonar agudo.
Derrame pleural laminar bilateral.
Atelectasias subsegmentarias bibasales confluentes.

PLAN

- Paciente que ingresa por cuadro de CEG, fiebre, tos con expectoración, ingresa con oxigenoterapia, dentro de estudio destaca atelectasias bibasales, microbiología negativa, PPII levemente elevados, sedimento de orina inflamatorio. Cobertura ATB biasociada con ceftriaxona/azitromicina. Pendiente ajuste segun UC.
Actualmente 1 L NRC.
- Se indica KCl via oral.

Diagnósticos

Insuficiencia respiratoria aguda
Obs atelectasias sobreinfectadas?
ITU
Hipokalemia leve
Hiponatremia leve
Antecedentes tetraplejia por impacto de bala

Se deriva a UHD.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria aguda -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

En epicrisis

Plan Post Alta

Reposo relativo
Regimen comun
KNTR
O2 para sat > 92%
Ceftriaxona 2 gr al día EV
Azitromicina 500 mg al día VO

Fecha Epicrisis : 10/01/2026 16:16

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 10-01-2026 16:16:40

Página 3 de 3

Paracetamol 1 gr c/8 hrs VO
Ketoprofeno 50 mg c/12 hrs VO
Tratamiento de base

Indicaciones

Tipo de Reposo :
Régimen Alimentario :
Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Nicole Gutierrez Zapata
Médico Tratante (Staff)